

Số: 80 /QĐ-BVPS

Cần Thơ, ngày 27 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy trình Đánh giá dự trữ buồng trứng” của khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-SYT ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học công nghệ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quy định số 2605/QĐ-SYT ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Khoa học công nghệ Bệnh viện Phụ sản về việc thông qua “Quy trình Đánh giá dự trữ buồng trứng”;

Xét đề nghị của Hội đồng Khoa học công nghệ Bệnh viện Phụ sản;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Phụ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

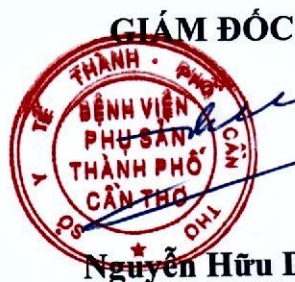
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình Đánh giá dự trữ buồng trứng” của khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các khoa, phòng, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHTH, TCCB.

GIÁM ĐỐC



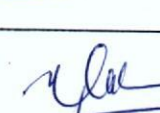
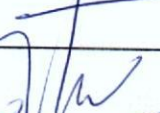
Nguyễn Hữu Dự

BẢN GỐC**QUY TRÌNH ĐĂNG HIỆU LỰC**

Quy trình đánh giá dự trữ buồng trứng

Mã tài liệu: CM-HM-19

	BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN	Mã tài liệu	CM-HM-19
		Phiên bản	5.0
	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ DỰ TRỮ BUỒNG TRỨNG	Ngày hiệu lực	27.01.2021
		Số trang	08

	Họ tên	Chức vụ	Ký tên	Ngày
Biên soạn	BS. NGUYỄN THỊ THANH NGÂN	Nhân viên		22/12/2020
Biên soạn	CNĐDPS. TRẦN THỊ OANH	Nhân viên		22/12/2020
Biên soạn	HS. PHAN THỊ KIM LIÊNG	Nhân viên		22/12/2020
Xem xét	THS. BS. NGUYỄN PHAN VINH	Trưởng khoa		06/01/2021
Phê duyệt	BS. CKII. NGUYỄN HỮU DỰ	Giám đốc		18/01/2021

**THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU**

Số phiên bản	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày sửa đổi	Người sửa đổi

Tài liệu nội bộ

1. Mục đích

Quy trình chuẩn hóa các bước thực hiện đánh giá dự trữ buồng trứng.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này được áp dụng tại khoa Hỗ trợ sinh sản khi cần đánh giá dự trữ buồng trứng của khách hàng nữ đến khám tại khoa.

3. Trách nhiệm

- Tất cả các bác sĩ, hộ sinh có trách nhiệm thực hiện đúng theo các bước của quy trình.
- Phụ trách quản lý chất lượng khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý chung về tài liệu.

4. Định nghĩa và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa

Dự trữ buồng trứng là khái niệm mô tả số lượng các nang noãn còn lại ở buồng trứng. Dự trữ buồng trứng giảm theo tuổi (sau 25 tuổi) và là một trong những nguyên nhân chính làm giảm các chức năng sinh sản của phụ nữ.

4.2. Chữ viết tắt

AMH	Anti-muller hormone
BS	Bác sĩ
DTBT	Dự trữ buồng trứng
HS	Hộ sinh
NAASI	Quy trình nhận diện người bệnh. Bao gồm: Name - Họ tên; Age - Năm sinh; Address - Địa chỉ; Service - Dịch vụ; ID - Vòng tay nhận diện và số vào viện.

5. Nội dung

5.1 Nguyên lý

Đánh giá dự trữ buồng trứng là việc định lượng các hormone và siêu âm đếm nang noãn thứ cấp đầu chu kỳ (AFC – Antral Follicle Count) dựa vào cơ chế điều hòa của trục nội tiết sinh sản hạ đồi – tuyến yên – buồng trứng.

5.2 Kiểm tra chất lượng

Đảm bảo tuân thủ quy trình thông qua việc thực hiện bảng kiểm (phụ lục 1)

5.3. An toàn

Không áp dụng

5.4 Các bước thực hiện**5.4.1 Bất kì thời điểm nào trong chu kì kinh nguyệt**

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả
BS, HS	Bước 1: Nhận diện người bệnh	Nhận diện theo quy trình NAASI
BS, HS	Bước 2: Chỉ định xét nghiệm	Cho chỉ định xét nghiệm máu AMH
BS, HS	Bước 3: Nhận diện người bệnh trước khi trả kết quả	Nhận diện lại theo quy trình NAASI
BS	Bước 4: Đánh giá dự trữ buồng trứng	Kết hợp dựa theo tuổi và kết quả AMH, so với bảng tham chiếu để đánh giá dự trữ buồng trứng.
BS	Bước 5: Xử trí	-DTBT thấp: Tìm nguyên nhân (nếu có); Xem xét yếu tố chồng, tư vấn Thụ tinh trong ống nghiệm - Xin noãn. -DTBT bình thường: Xem xét yếu tố chồng để có hướng xử trí phù hợp. -DTBT cao: Dựa vào dấu hiệu lâm sàng (kinh nguyệt không đều, rụng lông bất thường,...) chỉ định thêm các XN chuyển hóa. Xem xét yếu tố chồng để có hướng xử trí phù hợp.
HS	Bước 6: Trả phiếu hẹn	Ghi phiếu hẹn theo chỉ định BS



5.4.2 Thời điểm N2 – N4 vòng kinh

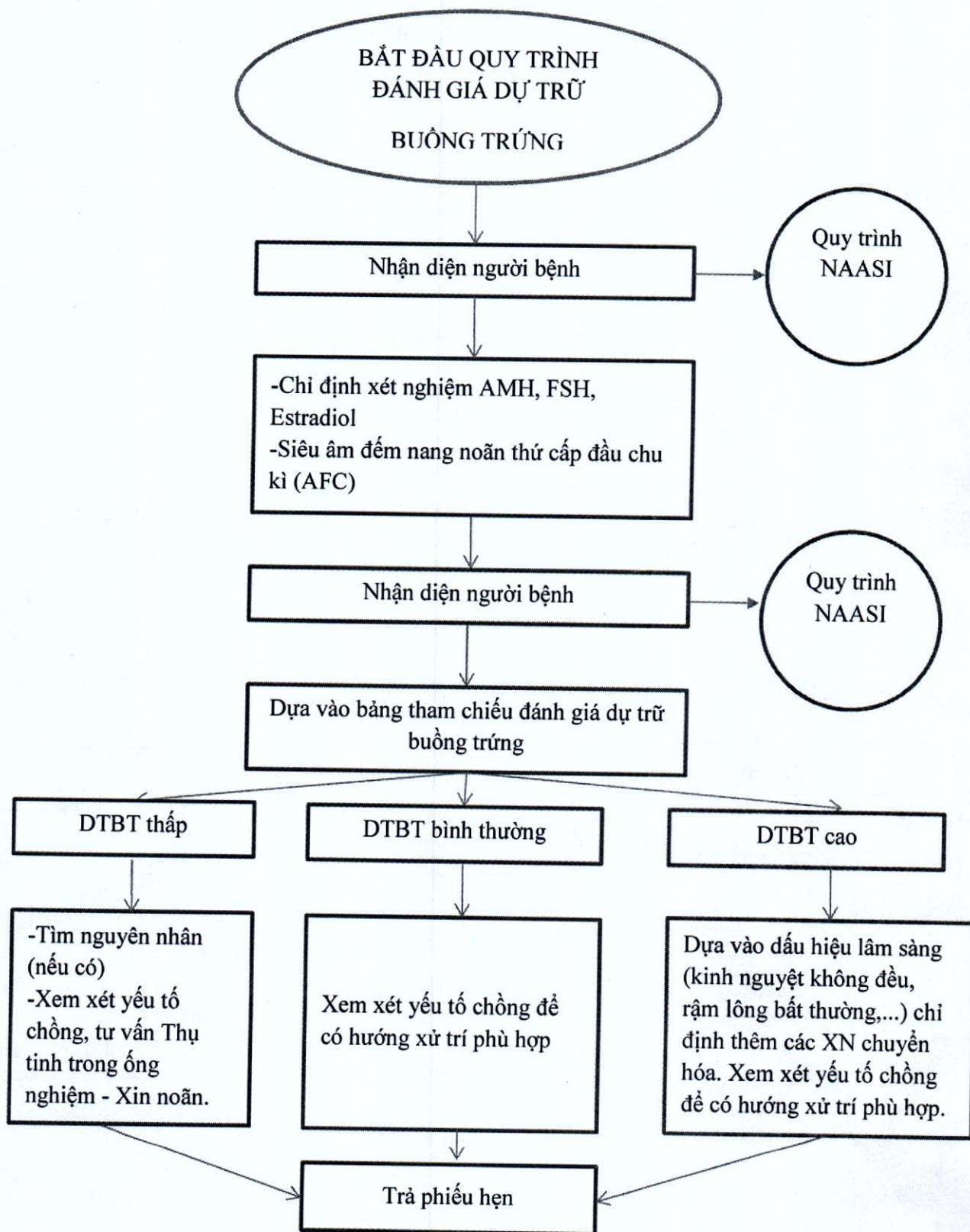
Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả
BS, HS	Bước 1: Nhận diện người bệnh	Nhận diện theo quy trình NAASI
BS, HS	Bước 2: Chỉ định xét nghiệm	-Cho xét nghiệm máu: AMH, FSH, Estradiol. -Siêu âm đếm nang noãn thứ cấp đầu chu kì (AFC)
BS, HS	Bước 3: Nhận diện người bệnh trước khi trả kết quả	Nhận diện lại theo quy trình NAASI
BS	Bước 4: Đánh giá dự trữ buồng trứng	Kết hợp dựa theo tuổi và kết quả AMH, FSH, Estradiol. So với bảng tham chiếu để đánh giá dự trữ buồng trứng.
BS	Bước 5: Xử trí	-DTBT thấp: Tìm nguyên nhân (nếu có); Xem xét yếu tố chồng, tư vấn Thụ tinh trong ống nghiệm - Xin noãn. -DTBT bình thường: Xem xét yếu tố chồng để có hướng xử trí phù hợp. -DTBT cao: Dựa vào dấu hiệu lâm sàng (kinh nguyệt không đều, rụng lông bất thường,...) chỉ định thêm các XN chuyển hóa. Xem xét yếu tố chồng để có hướng xử trí phù hợp.
HS	Bước 6: Trả phiếu hẹn	Ghi phiếu hẹn theo chỉ định BS

Bảng tham chiếu

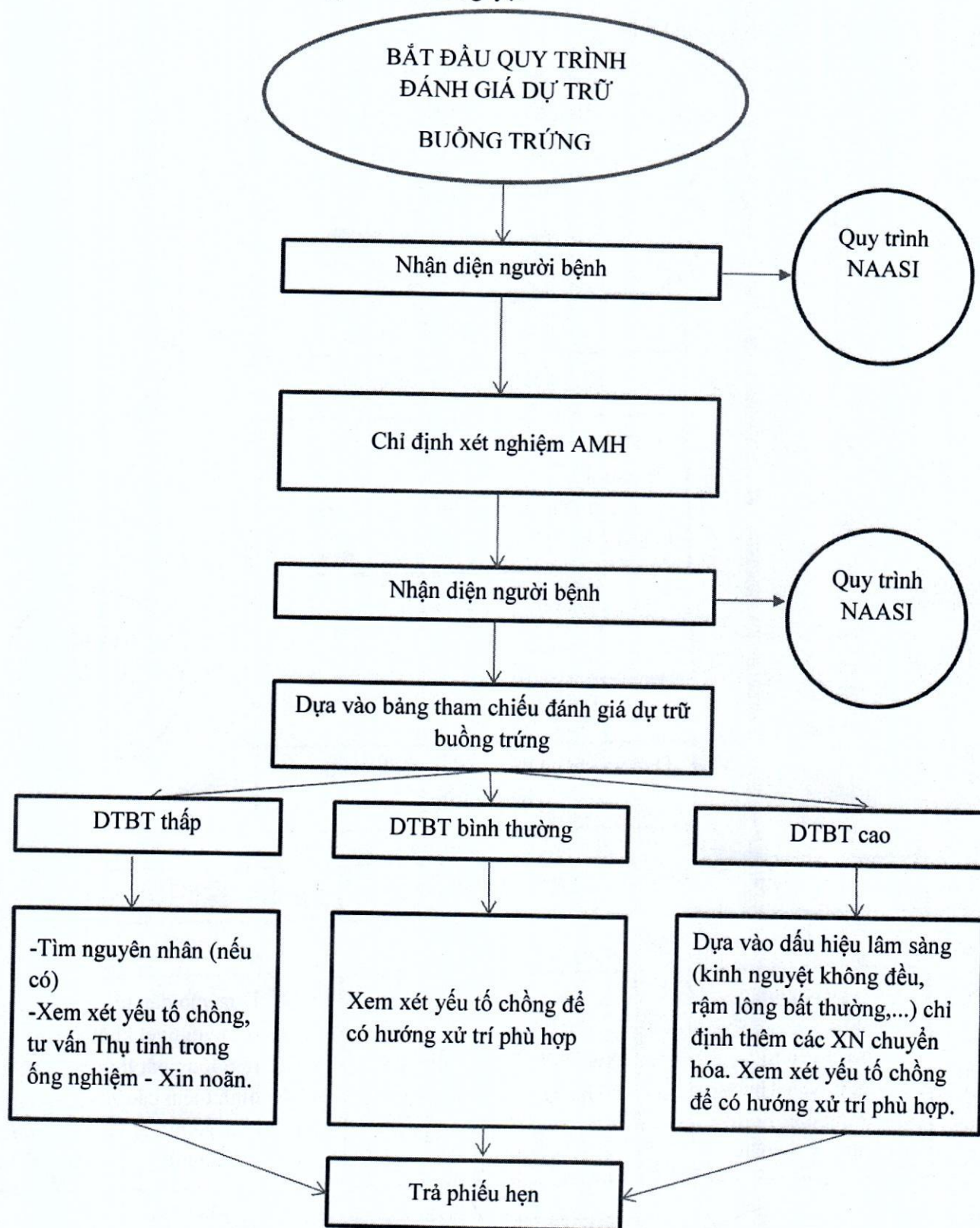
Dự trữ buồng trứng	Thấp	Bình thường	Cao
AMH (ng/mL)	<2	2 – 11,5	> 11,5
FSH (U/L) đầu chu kì	≥ 10	5-10	
AFC đầu chu kì	<5	≥ 5	
Estradiol đầu chu kì (pg/mL)	< 25 hay >80	25-80	

6. Lưu đồ

6.1 Thời điểm N2- N4 vòng kinh



6.2 Bất kì thời điểm nào trong chu kì kinh nguyệt



7. Lưu trữ hồ sơ

Quy trình được lưu trữ vĩnh viễn theo Thông tư 53/2017/TT-BYT, ban hành ngày 29/12/2017: Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế.

Hồ sơ được lưu 20 năm theo Thông tư 57/2015/TT-BYT ngày 30/12/2015: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

8. Tài liệu liên quan

-Phác đồ Bệnh viện phụ sản năm 2020, Khoa Hỗ trợ sinh sản, “Khám một cặp vợ chồng hiếm muộn”.

-Quy trình nhận diện người bệnh NAASI

9. Tài liệu tham khảo

- Hồ Mạnh Tường (2012), “Anti-muller hormone (AMH) và các ứng dụng”, Tạp chí Phụ Sản, Tập 10, Số 3, Tháng 7 – 2012.

- Dayal M, Sagar S, Chaurasia A, Singh U. Anti-mullerian hormone: a new marker of ovarian function. J Obstet Gynaecol India. 2014;64(2):130-133. doi:10.1007/s13224-013-0482-3.

10. Phụ lục

Bảng kiểm thực hiện đánh giá dự trữ buồng trứng

Phụ lục

	KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN	Mã tài liệu: CM-HM-24
	BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ DỰ TRỮ BUỒNG TRỨNG	Phiên bản: 5.0
		Ngày hiệu lực:
		Số trang: 08

Họ và tên BN: Năm sinh:

Ngày thực hiện:

Người thực hiện:

Người kiểm tra:

Thời điểm đánh giá:

(C: Có; K: Không)

*Bất kì thời điểm nào của chu kì kinh nguyệt:

Công việc	C	K
Nhận diện người bệnh theo Quy trình NAASI		
Cho chỉ định xét nghiệm máu AMH.		
Nhận diện lại theo quy trình NAASI		
Kết hợp dựa theo tuổi và kết quả AMH, so với bảng tham chiếu để đánh giá dự trữ buồng trứng.		
Ghi phiếu hẹn theo chỉ định BS		
Trả phiếu hẹn		

*Thời điểm N2- N4 vòng kinh:

Công việc	C	K
Nhận diện người bệnh theo Quy trình NAASI		
Cho chỉ định xét nghiệm máu AMH, FSH, Estradiol, Inhibin B		
Siêu âm đếm nang noãn thứ cấp đầu chu kì (AFC)		
Nhận diện lại theo quy trình NAASI		
Kết hợp dựa theo tuổi và kết quả AMH, FSH, Estradiol, Inhibin B, AFC, so với bảng tham chiếu để đánh giá dự trữ buồng trứng.		
Ghi phiếu hẹn theo chỉ định BS		
Trả phiếu hẹn		